

# preguntas-farma-1o-parcial.pdf



saramaro



Farmacología y Farmacoterapia



4º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid  
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi  
con 1 coin**



Después

**WUOLAH**



RESERVA YA  
TU PLAZA



A un paso  
de la uni



1. Cual de las siguientes características no se estudian en la farmacodinamia de un fármaco?
  - a. Mecanismo de acción
  - b. Efectos terapéuticos
  - c. Retención de tejidos
  - d. Efectos tóxicos
  - e. Tipo de receptor al que se une para ejercer su efecto
2. Qué característica tiene la fracción ionizada de un fármaco?
  - a. Se elimina por orina muy fácilmente
  - b. Se favorece en un fármaco ácido en un entorno ácido
  - c. Se favorece en un fármaco ácido en un entorno básico
  - d. Un fármaco no puede encontrarse en esta forma en el organismo
  - e. Las opciones a y c son correctas
3. Cual de los siguientes fármacos no se une a un receptor para ejercer su efecto?
  - a. Un laxante por contacto
  - b. Un fármaco de acción específica
  - c. El ibuprofeno
  - d. Un agonista simpaticomimético
  - e. Un antagonista muscarínico
4. Señala el binomio correcto:
  - a. Farmacognosia-estudio de la influencia de los genes en el efecto de las drogas
  - b. Farmacología aplicada-estudio de las propiedades de las drogas
  - c. Tecnología farmacéutica- estudio de la aplicación racional de los medicamentos en el ser humano
  - d. Las opciones a y c son correctas
  - e. No hay ninguna correcta
5. Un fármaco inductor enzimático puede generar:
  - a. Toxicidad
  - b. Ineficacia
  - c. Aumento de la velocidad de metabolismo
  - d. Disminución de la velocidad de metabolismo
  - e. Las opciones b y c son correctas
6. Respecto a la afirmación “la vía de administración intramuscular presenta una mayor velocidad de absorción que la administración por vía subcutánea”, señala la opción correcta:
  - a. Es cierta solamente en pacientes pediátricos
  - b. Es cierta ya que los músculos están más vascularizados que la zona subcutánea
  - c. Es cierto solamente en pacientes ancianos
  - d. No es cierta

- e. Es cierto debido a la diferencia del tejido adiposo de las dos zonas de administración
7. Señala la opción correcta acerca del volumen de distribución:
- El volumen de distribución aparente se calcula para saber el volumen que ocupará un fármaco en el organismo
  - No depende del grado de unión del fármaco a proteínas plasmáticas
  - Si es bajo implica una elevada unión del fármaco a proteínas plasmáticas
  - Es un parámetro farmacodinámico
  - Todo es correcto
8. Como se acelera la salida de un fármaco básico del organismo que se está eliminando por vía renal?:
- Acidificando la orina
  - Basificando la orina
  - Neutralizando la orina
  - Las opciones a y c son correctas
  - No se puede acelerar la eliminación de un fármaco
9. Un fármaco presenta una elevada vida media. ¿Qué podría sospechar que está sucediendo?
- Que fue administrado junto con un inhibidor enzimático
  - Que fue administrado junto con un inductor enzimático
  - Que el fármaco sufre un ciclo entero hepático
  - Las opciones a y c son correctas
  - Las opciones b y c son correctas
10. Tras la administración de un fármaco se observa que aumenta la concentración de AMPc en el interior de las células del tejido diana. ¿A qué tipo de receptor podría estar uniéndose el fármaco?
- Receptores acoplados a proteína G
  - Receptores acoplados a canal iónico
  - Bomba transportadora
  - Enzima
  - Receptores nucleares
11. El receptor nicótico está formado por una subunidad receptora a la que se unen los fármacos modificando el estado del canal de sodio asociado al mismo. Se trata de una diana farmacológica denominada:
- Receptores acoplados a proteína G
  - Receptores acoplados a canal iónico
  - Bomba transportadora
  - Enzima
  - Canal iónico
12. En una gráfica de  $[FR]$  frente a  $\log [F]$  se observan dos representaciones gráficas desplazadas literalmente la una respecto a la otra. Señala la opción correcta:

- a. Ambos fármacos poseen la misma afinidad
  - b. Ambos fármacos poseen la misma  $K_a$
  - c. Podemos asegurar que ambos fármacos son agonistas parciales
  - d. Podemos asegurar que ambos fármacos son agonistas puros
  - e. Nada es correcto
13. ¿Qué representa la pendiente en una gráfica de respuesta frente a los[F]?:
- a. La toxicidad
  - b. La seguridad
  - c. La afinidad
  - d. La eficacia
  - e. Las opciones a y b son correctas
14. ¿Cuál de las siguientes vías de eliminación es la segunda mas frecuente después de la renal?:
- a. Rectal
  - b. Biliar
  - c. Sudor
  - d. Leche materna
  - e. Respiración
15. Señala la opción incorrecta acerca de las reacciones de fase II del metabolismo:
- a. Disminuye la hidrosolubilidad del fármaco
  - b. Se generan principalmente en el hígado
  - c. Su resultado es un metabolismo inactivo, tóxico o activo
  - d. Pueden modificarse por la edad
  - e. Se trata de una reacción donde se conjuga al fármaco a una sustancia endógena muy hidrosoluble
16. Se administran dos fármacos con acciones opuestas fisiológicas. ¿Qué tipo de antagonista se está generando?
- a. Antagonista químico
  - b. Antagonista competitivo reversible
  - c. Antagonista no competitivo
  - d. Antagonista competitivo irreversible
  - e. Antagonista fisiológico
17. Un agonista adrenérgico, señale la correcta:
- a. Puede estimular receptores alfa y beta
  - b. Puede generar vasodilatación
  - c. Está contraindicado en el asma
  - d. Actúa sobre receptores muscarínicos de órganos diana
  - e. Actúa sobre receptores nicotínicos de órganos diana
18. ¿Qué mecanismo de acción puede tener un fármaco que mimetiza la acción de la noradrenalina en un órgano inervado por el sistema nervioso simpático?
- a. Antagonista adrenérgico

VENTE  
A VIVIR A  
VALENCIA



A un paso  
de la uni



- b. Antagonista muscarínico
- c. Inhibidor de la recaptación de noradrenalina
- d. Inhibidores de la mao
- e. Las opciones c y d son correctas

19. A qué tipo de receptor puede unirse la acetil colina en el organismo?

- a. Alfa y beta
- b. Muscarínico y nicotínico
- c. Alfa y muscarínico
- d. Beta y nicotínico
- e. Nada es correcto

20. Cual de los siguientes fármacos podría utilizarse para el tratamiento tópico del glaucoma?:

- a. Pilocarpina, parasimpaticomimético
- b. Un fármaco que aumente secreciones
- c. Un fármaco parasimpaticomimético
- d. Un fármaco colinérgico
- e. Todo es correcto

21. Cual de los siguientes fármacos estaría contraindicado en un paciente asmático?

- a. Agonista muscarínico
- b. Antagonista muscarínico
- c. Anticolinesterásico
- d. Anticolinérgico
- e. Las opciones a y c son correctas

22. Si la intoxicación por muscarina provoca la muerte por una parada cardiorrespiratoria, ¿qué tipo de sustancia podría ser la muscarina?

- a. Simpaticomimética
- b. Agonista de receptores alfa
- c. Agonistas de receptores beta
- d. Colinérgica
- e. Parasimpaticolítica

23. Qué acción ejerce un fármaco anticolinesterásico sobre el corazón?

- a. Aumenta funciones cardíaca
- b. Disminuye funciones cardíacas
- c. No ejerce ningún efecto
- d. El mismo efecto que un fármaco anticolinérgico
- e. Las opciones b y d son correctas

24. Como se puede tratar una intoxicación de un fármaco básico?

- a. Basificando la orina+ diurético
- b. Acidificando la orina + diurético
- c. Neutralizando la orina + diurético

- d. Carbón activo
  - e. Ninguna
25. Que debe cumplir un F para poder atravesar las membranas plasmáticas por difusión pasiva?
- a. Hacerlo en contra de gradiente concentración
  - b. Estar mayoritariamente en su forma no ionizada
  - c. Hacerlo gastando energía
  - d. Estar mayoritariamente en su forma hidrosoluble
  - e. Estar mayoritariamente en su forma polar
26. Señala CORRECTA acerca farmacocinética de un F
- a. Todos los F se metalizan
  - b. La vía de eliminación mas frecuente es la renal
  - c. Todos los F se absorben
  - d. La dieta no modifica la distribución
  - e. En su distribución se une siempre a una proteína plasmáticas
27. Qué parámetros afectan directamente a la farmacocinética de un fármaco administrado por vía oral?
- a. Acné
  - b. EL estado de animo del paciente
  - c. Una hiperalbuminemia
  - d. Una insuficiencia renal
  - e. Opciones c y d son correctas
28. Receptores acoplados a la proteína g formados por:
- a. 1 subunidad
  - b. 2 subunidades
  - c. 3 subunidades
  - d. 4 subunidades
29. Un antagonismo farmacológico puede ser:
- a. Químico
  - b. Farmacocinético
  - c. Competitivo reversible
  - d. Competitivo irreversible
  - e. Todo es correcto
30. Que sustancias son las responsables del efecto de una droga?
- a. Excipiente
  - b. Ppo activo
  - c. Placebo
  - d. Todo es correcto
  - e. Ninguna de las anteriores





# PARA QUIEN QUIERE INDEPENDIZARSE SIN QUE SEA UN MARRÓN.

Sí, esta Resi  
*también* es para ti.

RESERVA YA  
TU PLAZA



Pamplona, Sabadell,  
Salamanca, Sevilla, Valencia



31. Como se denomina la atracción química entre un F y un receptor?
- a. Afinidad
  - b. Especificidad
  - c. Actividad intrínseca
  - d. Selectividad
  - e. Nada es correcto
32. Las curvas de niveles plasmáticos estudian:
- a. La velocidad de absorción de los fármacos
  - b. La afinidad de los fármacos por su receptor
  - c. El efecto del fármaco por su receptor
  - d. Nada es correcto
33. Señala incorrecta acerca sistema nervioso simpático
- a. Es involuntario
  - b. Su estimulo genera taquicardia
  - c. Esta formado por una unica fibra que conecta el órgano inervado con la medula
  - d. El NRT que ejerce sus funciones sobre órgano inervado es la noradrenalina
  - e. Forma parte del sistema nervioso vegetativo
34. El salbutamol (agonista de receptores B2 de pulmones) es útil para el tratamiento de:
- a. Hipertensión
  - b. Taquicardia
  - c. Retención urinaria
  - d. Asma
  - e. Estreñimiento
35. Señala la opción CORRECTA:
- a. Un farmaco parasimpaticolítico ejerce una acción contraria a la acetilcolina
  - b. Un farmaco puede carecer al 100% de efectos adversos la toxicidad de un fármaco se puede medir en la pendiente de la gráfica que representa efecto frente a  $\log(F)$
  - c. La farmacocinética puece condicionar la farmacodinamia de un fármaco
  - d. Las opciones c y a son correctas
36. La parte de la Farmacología que estudia las propiedades de las drogas se denominan:
- a. Farmacodinamia
  - b. Farmacognosia
  - c. Farmacogenética
  - d. Farmacia galénica
  - e. Farmacoterapia



VENTE  
A VIVIR A  
VALENCIA



A un paso  
de la uni



37. ¿Qué es un medicamento?:

- a. Principio activo + excipiente
- b. Excipiente
- c. Principio activo
- d. Fármaco + principio activo
- e. Forma Farmacéutica

38. Señale la opción correcta respecto a los fármacos liposolubles

- a. Son siempre mas potentes que los hidrosolubles
- b. No puedes atravesar BHE
- c. Se introducen en esferas de liposol para poder administrarlo
- d. Se introducen via intravena
- e. Todo es falso

39. Que características poseen en común la difusión facilitada y transporte activo

- a. Los dos mecanismos de transporte de F se realizan con gasto ATP y son saturables
- b. Los dos mecanismos de transporte de F se realizan sin gasto ATP a favor gradiente
- c. Los dos mecanismos de transporte de F se realizan con gasto ATP a favor gradiente
- d. Los dos mecanismos de transporte son inhibibles y saturables
- e. Los dos mecanismos de transporte de F se realizan en contra gradiente y son saturables

40. La absorción de un F puede verse afectada por

- a. Las características fisicoquímicas del fármaco
- b. La vascularisation en la zona de admin del fármaco
- c. Las permeabilidad de las membranas
- d. La A y C son correctas
- e. Todas son correctas

41. Todos aquellos factores que aceleren el metabolismo de un fármaco provocaran:

- a. Un aumento de tiempo de permanencia del fármaco en el organismo
- b. Una mayor eficacia del fármaco
- c. Un posible aumento en su toxicidad
- d. Una disminución de tiempo de permanencia del fármaco en el organismo
- e. B y D son correctas

42. Senale la opción INCORRECTA acerca de la distribución de los fármacos:

- a. La unión entre el farmaco y la proteina plasmática es reversible
- b. La salida del fármaco de los vasos se realiza con gasto energético
- c. Sólo el farmaco libre es activo

- d. La unión de los fármacos a proteínas plasmáticas actúa como reservorio del fármaco en el organismo
  - e. Los fármacos pueden quedar retenidos en ciertos tejidos por los que sientan afinidad
43. Señale la opción INCORRECTA:
- a. Los fármacos antagonistas se unen a un receptor
  - b. Los fármacos agonistas se unen a un receptor
  - c. La unión más frecuente entre fármaco y receptor son los enlaces iónicos
  - d. La afinidad de un fármaco por su receptor no varía al variar el número de enlaces entre ambas moléculas
  - e. La unión entre fármaco y receptor es generalmente reversible
- 44.Cuál de las siguientes situaciones podría prolongar la administración de un fármaco en organismo?:
- a. Administrarlo conjuntamente con conductor enzimático
  - b. Que el fármaco sufra ciclo enterohepático para su eliminación
  - c. administrarlo junto con un F que aumente su concentración ionízala en orina
  - d. ser administrado en un paciente con insuficiencia renal y hepática
  - e. Las opciones B y D son correctas
45. ¿Cual de las siguientes fases farmacocinéticas NO la sufre un fármaco administrado por vía intravenosa?
- a. Absorción
  - b. Distribución
  - c. Metabolismo
  - d. Eliminación
  - e. Excreción
46. Se administra un fármaco con una absorción pH dependiente junto con otro fármaco que modifica el pH del lugar de absorción del primer fármaco. ¿Qué tipo de antagonismo se podría generar?:
- a. Farmacocinético
  - b. Farmacodinámico
  - c. Químico
  - d. Competitivo reversible
  - e. Competitivo irreversible
47. ¿Qué fase farmacocinética puede verse alterada si se administra un fármaco a un paciente con diarrea?:
- a. Absorción
  - b. Distribución
  - c. Metabolismo
  - d. Eliminación
  - e. Todo es correcto
48. La especificidad de un fármaco viene determinada principalmente por:

- a. Su vía de administración
  - b. Su forma farmacéutica
  - c. Su afinidad por receptores específicos
  - d. Su vía de eliminación
  - e. Su metabolismo
49. En cuál de los siguientes pacientes estaría más acelerado su metabolismo farmacológico?:
- a. Adolescentes
  - b. Ancianos
  - c. Adultos
  - d. Paciente con insuficiencia renal
  - e. Paciente con insuficiencia hepática
50. Un fármaco estimulante selectivo del receptor beta 2 será útil principalmente para el tratamiento de:
- a. Asma
  - b. Parada cardíaca
  - c. Congestión
  - d. Incontinencia urinaria
  - e. Diarrea
51. Los fármacos que se excretan
- a. No sufren transformaciones químicas.
  - b. Sufren transformaciones químicas
  - c. Son nocivos
  - d. No producen efecto alguno en el organismo
  - e. Los fármacos no se excretan
52. Señale la opción INCORRECTA:
- a. La absorción consiste en el paso del fármaco a la sangre
  - b. En la eliminación los fármacos sufren ciclo enterohepático si es por vías
  - c. El metabolismo consiste en la transformación química del organismo
  - d. Los fármacos que se absorben generan efecto sistémico
  - e. Los fármacos se unen generalmente a proteína albúmina
53. Los fármacos agonistas:
- a. Actúan sobre los receptores de una molécula endógena imitando los efectos de esta sobre el organismo.
  - b. Actúan sobre receptores de una sustancia endógena bloqueándolo, inhibiendo los efectos de dicha sustancia sobre el organismo.
  - c. Actúan sobre los receptores de una molécula endógena sin imitar los efectos de esta sobre el organismo.
  - d. No existen los fármacos agonistas.
  - e. Actúan sobre los receptores de una molécula exógena sin imitar los efectos de esta sobre el organismo.

RESERVA YA  
TU PLAZA



A un paso  
de la uni



54. Gracias a las enzimas los fármacos consiguen:

- Inhibir rutas metabólicas.
- Inhibir enzimas degradativas.
- Inhibir enzimas degradativas de cofactores indispensables para la biosíntesis de una sustancia concreta.
- Las opciones a y c son correctas
- Todas las opciones son verdaderas

55. Se denomina a la ciencia que estudia la influencia de los genes sobre los efectos de los fármacos:

- Terapia génica.
- Toxicología medicamentosa.
- Farmacogenética
- Farmacodinamia.
- Farmacognosia

56. ¿Cuál de las siguientes vías de administración NO se corresponde con una vía de administración parenteral?:

- Epidural,
- Rectal
- Transdérmica.
- Intramuscular.

57. Se administra por vía oral un antibiótico para el tratamiento de una infección intestinal. Señale la opción CORRECTA:

- Para ser eficaz, el fármaco debe presentar una elevada biodisponibilidad por la vía utilizada
- La absorbancia del fármaco no es necesaria para garantizar su eficacia terapéutica
- El fármaco debe absorberse al menos en parte para ser eficaz
- Todos los antibióticos se metabolizan en el hígado
- Si el fármaco se absorbe en parte se eliminará por completo por heces

58. Respecto a la unión de los fármacos con proteínas plasmáticas, señale la opción INCORRECTA:

- Preferentemente, los fármacos se unen a albuminas para su distribución
- Una elevada unión a proteínas plasmáticas condiciona una baja estancia del fármaco en el organismo
- Si dos fármacos necesitan unirse a proteínas plasmáticas para su distribución, pueden generar interacciones si se administran conjuntamente
- Una elevada unión del fármaco a proteínas plasmáticas, condiciona un bajo volumen de distribución del fármaco
- El fármaco unido a proteína plasmática no es capaz de atravesar la pared de los capilares

59. ¿Qué debería hacerse, generalmente, para ajustar la dosis de un fármaco que se metaboliza en hígado administrado en un paciente con alcoholismo crónico?:
- Aumentar la dosis
  - Disminuir la dosis
  - Administrar la misma dosis que en un paciente no alcohólico
  - Aumentar la dosis y disminuir en días alternos
  - Todo es incorrecto
60. Señale la opción INCORRECTA respecto a la eliminación de fármacos:
- Se debe sospechar que cualquier fármaco puede, eliminarse en parte a través de la leche materna
  - Los diuréticos deben eliminarse - al menos en parte - a través del riñón
  - Un fármaco hidrosoluble puede eliminarse por orina sin metabolizado previamente
  - La filtración es el único mecanismo mediante el cual un fármaco puede penetrar en el interior de la neurona para ser eliminado por orina
  - Las opciones a y e son correctas
61. Se observa que, tras la unión de un fármaco con .... receptor, aumenta la concentración intracelular de DAG (diacilglicerol) ¿Sobre qué tipo de receptor se sospecha que ha actuado el fármaco?
- Canal iónico asociado
  - Canal iónico asociado a receptor
  - Receptor acoplado a proteína G
  - Enzima
  - ADN
62. La  $K_d$  de un fármaco A = 20 mg/ml y la de un fármaco B = 157 mg/ml Señale la opción CORRECTA:
- A presenta menor afinidad que B
  - A y B presentan la misma afinidad
  - B presenta menor afinidad que A
  - La  $K_A$  de un fármaco NO puede relacionarse con su afinidad
  - Nada es correcto
63. La pendiente de la gráfica efecto frente  $\log(FR)$ , representa:
- La seguridad del fármaco
  - Potencia del fármaco
  - Afinidad del fármaco
  - Eficacia del fármaco
  - La  $K_A$  del fármaco



64. Señale la opción INCORRECTA

- a. Un principio activo puede ser agonista sobre un receptor
- b. Una modificación en la estructura química de un fármaco, puede modificar su afinidad sobre el receptor
- c. La farmacognosia estudia las características organolépticas de los fármacos sintéticos
- d. La excreción es la salida de los fármacos hidrosolubles a través de la orina
- e. Todo es correcto

65. Un fármaco A es agonista para un receptor y un fármaco B es antagonista reversible sobre el mismo receptor. ¿Cómo se puede revertir el efecto del fármaco B?:

- a. Aumentando la concentración de A
- b. Aumentando la concentración de B
- c. aumentando la concentración de ambos fármacos
- d. No se puede revertir
- e. Todo es correcto

66. Señale la opción INCORRECTA

- a. Un profármaco se activa a través del metabolismo
- b. Un fármaco antagonista no genera efecto terapéutico
- c. Hay fármacos que generan efecto terapéutico con el ADN celular

67. Si un fármaco presenta una baja biodisponibilidad oral, la concentración del fármaco en sangre será baja si un paciente presenta taquicardia, sudoración? Y ... ¿con qué fármaco se sospecha que se ha intoxicado?

- a. Atropina
- b. Noradrenalina
- c. Acetilcolina
- d. Las opciones A y B correctas
- e. Nada es correcto

68. Cual de las siguientes vías de administración suele ser más lenta

- a. Sublingual
- b. Intramuscular
- c. Oral
- d. Topica
- e. Rectal

## EXAMEN OCTUBRE 2022

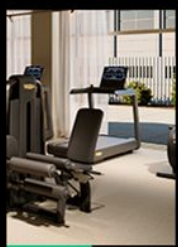
69. Cual de las siguientes acciones NO es propia de un AINEs a nivel sanguíneo?

- a. Anemia hemolítica
- b. Antiagregante plaquetario
- c. Anticoagulante
- d. Agranulocitosis

RESERVA YA  
TU PLAZA



A un paso  
de la uni



70. En un paciente con insuficiencia hepática, el fármaco...
  - a. Se metaboliza más despacio
  - b. Permanece más tiempo en el organismo
  - c. Todo es correcto
  - d. Puede generar toxicidad
71. La farmacodinamia estudia...
  - a. Efectos adversos
  - b. Usos terapéuticos
  - c. Mecanismos de acción de los fármacos
  - d. Todo es correcto
72. Qué órgano está más implicado en el metabolismo de AINEs?
  - a. Riñón
  - b. Sangre
  - c. Hígado
  - d. Cerebro
73. Señala la opción incorrecta acerca del Zafirlukast:
  - a. Inhibidor de la serotonina
  - b. Útil en el asma
  - c. Inhibe la acción de un eicosanoide
  - d. Antagonista de leucotrienos
74. El ibuprofeno es un derivado de:
  - a. Nada es correcto
  - b. Derivados del ácido arilacético
  - c. Derivado del ácido acetil salicílico
  - d. Derivado del ácido arilpropiónico
75. Un AINEs cuyo nombre finaliza en -coxib NO es:
  - a. Antiinflamatorio
  - b. Inhibidor de la COX2
  - c. Gastrolesivo
  - d. Analgésico
76. Cual de los siguientes fármacos es un inhibidor selectivo de la COX2?
  - a. Robecoxib
  - b. Naproxeno
  - c. Ibuprofeno
  - d. Paracetamol
77. Un fármaco ácido en medio ácido:
  - a. Es hidrosoluble
  - b. Difunde a través de una membrana
  - c. Está ionizado
  - d. Todas son correctas

78. Señala un fármaco útil en profilaxis del asma:
- Nedocromilo
  - Cromoglicato disódico
  - Ketotifeno
  - Todo es correcto
79. En qué fase de los ensayos preclínicos pueden estudiar los efectos adversos?
- Fase I; II, III y IV
  - Fase IV y V
  - Fase I y II
  - Unicamente en la etapa de farmacovigilancia
80. La farmacovigilancia también se denomina
- Fase I
  - Fase II
  - Fase IV
  - Fase III
81. Qué característica posee la unión fármaco receptor?
- Con afinidad
  - Reversible
  - Saturable
  - Todo es correcto
82. Qué característica debe poseer un fármaco para atravesar la BHE?
- Ser iónico
  - Ser polar
  - Ser básico
  - Ser liposoluble
83. La cimetidina es:
- Un antagonista de serotonina
  - Un antihistamínico antiulceroso
  - Un antihistamínico antialérgico
  - Un antagonista de leucotrienos
84. Qué tipo de enlace es el menos frecuente entre fármaco y receptor?
- Nada es correcto
  - Reversible
  - Irreversible
  - Iónico
85. El grado de atracción que siente un fármaco por su receptor se denomina:
- Especificidad
  - Selectividad
  - Afinidad
  - Atracción

86. Cual de las siguientes acciones no es propia de un AINEs a nivel sanguíneo?

- a. Anemia hemolítica
- b. Antiagregante plaquetario
- c. Anticoagulante
- d. Agranulocitosis

87. En un paciente con insuficiencia hepática, el fármaco....

- a. Se metaboliza más despacio
- b. Permanece más tiempo en el organismo
- c. Todo es correcto
- d. Puede generar toxicidad

88. Cual de los siguientes conceptos NO representa un sinónimo de fármaco?

- a. Principio activo
- b. Droga
- c. Molécula activa de un medicamento
- d. Excipiente

89. Como tomar un medicamento?.... estamos hablando de....

- a. Una contraindicación
- b. Interacción
- c. Posología
- d. Un efecto adverso

90. La dinoprostona es:

- a. Un antimigrañoso
- b. Un antiulceroso
- c. Un inductor del parto
- d. Un inhibidor del parto